



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نوال محمود احمد علي

المحافظة : القاهرة

الحي / المدينة : مدينه نصر الاول

العنوان : بلوك 46 المنطقه

التاسعه مدينه نصر اول القاهره

تاريخ تسجيل الإستماره : 03-10-2026

رقم البطاقة : 25611020102661 رقم التليفون : 01066264665

العمر(تاريخ الميلاد) : 02-11-1956 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

تعتمد صحة الأبحاث المرفقة

رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :

ملاحظات :

قسم :

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئيس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نوال محمود احمد علي National ID: 25611020102661	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نوال
محمود احمد على

بلوك ٤٦ - المنطقة التاسعة
مدينة نصر اول - القاهرة

١٩٥٦/١٧/٢٢ ٢٥٦١١٠٢٠١٠٢٦٦١

JA6744554

١١١٥٥٤٥٢٠٤

ماصو

٢٠٢١/٠٩ ٢٥٦١١٠٢٠١٠٢٦٦١

ربة منزل

أنثى
مسلمة
متزوجة

احمد احمد حسن احمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٩/١٢

١

اسم المريض بالإنجليزية: Nawal Mahmoud Ahmed	كود المريض: 98784
تاريخ التقرير: 2026/08/26 12:33:03 PM	السن: ٦٩ سنة, ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 55 years old female patient with left breast lump and skin ulcer.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The Left breast shows left UIQ posterior 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion measuring about 4.8x4.0 cm about 8 cm from the nipple with mild increased skin thickness
- **Ultrasound** correlating with mammography , irregular shaped hypoechoic spiculated lesion seen at 11-12 o'clock extending to the overlying skin (causing ulceration clinically)
- Normal nipple/areolar complex.

Left irregular shaped hypoechoic pathological lymph node with extracapsular extension measuring 2x1.5 cm.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Right LIQ regional benign looking calcification
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** Left UIQ locally advanced malignant mass lesion with ipsilateral pathological node with extracapsular extension for histopathological correlation.
- **Right breast (BIRADS 2):** benign calcification

*Much obliged,
Dr. Heba Ahmed, MD*

Pathology Report

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 3/09/2026, Cold ischemia time is 20 seconds.

Five greyish white tissue cores, ranging in length from 1.0 cm & 2.0 cm long, totally submitted.

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for; ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

- Histologic type: Invasive duct carcinoma
- DCIS: Minimal, solid, low grade.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolymphatic invasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 25%.

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- IPt:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).



رقعة رقم (4) - الدار الأولى - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987 - Nile Corniche - Msr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name	نوال محمود احمد	Case No.	362243
Sex/Age	Female 69 Y	Patient No.	26645
Registered Date	03/9/2026 08:16:35 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	23/9/2026 11:31:08 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:46:21 AM	Pathology No.	2839/26

- Her2: Ultralow (score 1+).

- Ki67%: 25%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة ٤ - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Msr El Qadima - Cairo, Egypt

اسم المريض بالإنجليزية: Nawal Mahmoud Ahmed	كود المريض: 98784
تاريخ التقرير: 2026/08/26 12:33:03 PM	السن: ٥٩ سنة, ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound

Clinical summary: 55 years old female patient with left breast lump and skin ulcer.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The Left breast shows left UIQ posterior 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion measuring about 4.8x4.0 cm about 8 cm from the nipple with mild increased skin thickness
- Ultrasound correlating with mammography , irregular shaped hypoechoic spiculated lesion seen at 11-12 o'clock extending to the overlying skin (causing ulceration clinically)
- Normal nipple/areolar complex.
- Left irregular shaped hypoechoic pathological lymph node with extracapsular extension measuring 2x1.5 cm.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Right LIQ regional benign looking calcification
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left UIQ locally advanced malignant mass lesion with ipsilateral pathological node with extracapsular extension for histopathological correlation.
- Right breast (BIRADS 2): benign calcification

Much obliged,
Dr. Heba Ahmed, MD